

压力性尿失禁 — 男性

WARWIKI

患者须知 · 前列腺手术后漏尿 — 用力或活动时发生

男性压力性尿失禁（SUI）是指膀胱受到突然压力时漏尿，例如咳嗽、站起、提重物或运动时。男性SUI几乎都与前列腺手术或放疗后控尿肌肉（括约肌）功能减弱有关。第一年内症状常自行改善，若未改善，目前有非常有效的治疗方法。

关于这种疾病

前列腺切除后，主要的**尿道括约肌**（控制排尿的阀门）负担加重，可能因此减弱。结果是用力时漏尿——从需要护垫的几滴到较多漏尿不等。这与**急迫性漏尿**（突发强烈尿意）不同，后者治疗方式有所差异；部分患者两者兼有。

病因

- **根治性前列腺切除术**（因癌症切除前列腺）— 最常见原因
- 其他前列腺手术或**盆腔放疗**
- 较少见：神经或膀胱疾病

漏尿通常**早期最严重**，随着愈合和盆底肌力量恢复，数周至数月内逐渐改善。

名词解释

压力性尿失禁

用力时漏尿——咳嗽、站起、提重物时发生。

括约肌

控制尿液的肌肉阀门，待您准备好再排尿。

前列腺切除术

切除前列腺的手术，男性SUI的常见原因。

盆底

通过锻炼来帮助控尿的肌肉群。

护垫测试

每天记录用垫数量，评估漏尿量。

男性吊带

放置于尿道下方的支撑装置，适用于轻中度漏尿。

可调节球囊（ProACT）

尿道两侧各一个可调节球囊，在诊室调节；一种微创选择。

人工尿道括约肌（AUS）

植入式装置（由您控制的袖套），适用于中重度漏尿。

会自行好转吗？ 通常会——前列腺手术后漏尿在前6至12个月内常自行改善，尤其是坚持盆底肌锻炼者。若约一年后仍有明显漏尿，可考虑男性吊带、可调节球囊或人工尿道括约肌，效果均很好。

如何诊断

- 询问漏尿发生的时机和程度（常以**每日护垫数**计算）
- **尿液检查**及排空情况评估
- 手术前：膀胱镜检查（cystoscopy），有时需进行膀胱功能测试

如何治疗（分步骤）

- 1 **盆底肌锻炼**（Kegel运动），建议在手术前后开始，同时控制饮水量和体重。
- 2 第一年内**观察改善情况**，期间按需使用护垫或防护用品。
- 3 **男性吊带**— 适用于持续轻至中度漏尿（无放疗史）。
- 4 **可调节球囊（ProACT）**— 轻至中度漏尿的另一微创选择；两个小球囊在诊室分次调节（放疗后不适用）。
- 5 **人工尿道括约肌（AUS）**— 中重度漏尿及放疗后的金标准选择。每项治疗均有专属说明单。

日常管理

- 坚持盆底肌锻炼——这是最基础的治疗。
- 恢复期间使用护垫或防护内衣，保持自信。
- 若夜间漏尿明显，限制晚间饮水和咖啡因摄入。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 排尿时灼痛、发热或**血尿**（可能感染）
- 突然**无法排尿**
- 漏尿加重而非改善

需要记住的三件事

1. 男性SUI几乎都由前列腺手术或放疗后括约肌减弱引起，第一年内通常会改善。
2. 盆底肌锻炼是基础；持续漏尿者，男性吊带或人工尿道括约肌效果很好。
3. 恢复最多等待一年再决定手术。如出现发热、血尿或无法排尿，请及时就诊。